

Profilaktyka *nawrotów*

AvPD jest **chroniczne** — terapia buduje *umiejętności*, nie „leczy”. Profilaktyka: 1 ekspozycja/tydzień + monitor wstydu + booster co 3 m-ce. Cel ≠ brak lęku; cel = **życie pełnią mimo lęku**.

CZAS: 12 min Pod koniec terapii

ŹRÓDŁO: Skodol i wsp. (2005, CLPS); Marlatt & Gordon (1985); Beck, Davis & Freeman (2015)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, dlaczego *schemat nie zanika* — staje się cichszy (sekcja 01). **2** · Poznasz **cztery filary planu utrzymania** (sekcja 02). **3** · Wypiszesz *swoje wczesne sygnały* nawrotu (sekcja 03). **4** · Poznasz **realistyczne oczekiwania**: cel nie jest brak lęku, cel jest życie zgodne z wartościami (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

AvPD ma przebieg **chroniczny** — celem terapii nie jest „wyleczenie”, ale zbudowanie *elastyczności i umiejętności* radzenia sobie ze schematem, który będzie się aktywował przez całe życie. Skodol i wsp. (CLPS, 2005, *Collaborative Longitudinal Personality Study*): zaburzenia osobowości **poprawiają się z czasem**, ale tylko u pacjentów **aktywnie utrzymujących** pracę zaczęłą w terapii. Pacjent kończy terapię z poczuciem „*jestem zdrowy/-a*”, przerywa ekspozycje, wraca do strefy komfortu. Po 6–12 miesiącach: schemat defektywności *reaktywuje się* przy pierwszej realnej krytyce — i pacjent ląduje w gorszym miejscu niż przed terapią („*nawet to mi nie pomogło*”). Schemat **nie zanika** — staje się *cichszy*. Ekspozycja go „uciszała” przez konkurencyjne dowody. Bez podtrzymania dowody się *dezaktualizują*, a schemat odzyskuje moc — szczególnie pod wpływem stresu, choroby, straty. Model *relapse prevention* Marlatta & Gordona (1985), adaptowany do PD przez Becka, Davisa & Freemana (2015), podkreśla rolę **wczesnych ostrzeżeń**.

01 Schemat nie zanika — staje się cichszy

PUŁAPKA „JUŻ JESTEM ZDROWY/-A”

Pacjent kończy terapię z poczuciem wyzdrowienia, przerywa ekspozycje, wraca do strefy komfortu. 6–12 mies. później pierwsza krytyka reaktywuje schemat — **regres głębszy niż przed terapią**.

REALISTYCZNY MODEL

Schemat zostaje *cichszy*, ale aktywuje się przy stresie, chorobie, stracie. Pacjent ma narzędzia, by go **rozpoznać i nazwać** — i nie wpaść w stary tryb na miesiące.

Klucz: ekspozycja „uciszała” schemat przez *konkurencyjne dowody*. Bez podtrzymania dowody się **dezaktualizują** — mózg lubi stare przewidywania. Po roku bez praktyki schemat odzyskuje moc, szczególnie pod wpływem stresorów. Profilaktyka to nie nadgorliwość — to *warunek* trwałej zmiany.

02 Cztery filary planu utrzymania

1 · REGULARNA HIGIENA SPOŁECZNA

Minimum 1 sytuacja społeczna/tydzień poza strefą komfortu. Nieważne jaka — ważne, że *regularnie*. To podtrzymanie konkurencyjnych dowodów.

2 · MONITOR WSTYDU

Krótki *check-in* raz w tygodniu: „*jak silny jest wstyd 0-10? co go aktywowało?*”. Wczesne wykrycie reaktywacji = wcześniej zareagujesz.

3 · BOOSTER SESSIONS

Sesja przypominająca **co 3-6 miesięcy** w pierwszym roku po zakończeniu terapii. Później co 6-12 miesięcy. To nie jest „powrót terapii” — to konserwacja.

4 · SAMOWSPÓŁCZUCIE WOBEC POTKNIĘĆ

„Potknięcie ≠ porażka. Zmiana jest *procesem*”. Powrót starych wzorców na chwilę — to normalne, nie dowód, że „nic nie zadziało”.

Klucz: plan profilaktyki musi być **spisany i realistyczny**. Lista 5-7 wczesnych sygnałów + odpowiadające im 5-7 działań („*jeśli zaczynam unikać 2 spotkania z rzędu → planuję jedno małe wejście w tym tygodniu*”). Bez konkretnego planu jest tylko deklaracja.

03 Moje wczesne sygnały nawrotu + odpowiedzi

SYGNAŁ 1 — JAKIE ZACHOWANIE?

— np. odwołanie 2 spotkań z rzędu

CO ZROBIĘ?

— konkretne mikrodziałanie w tym tygodniu

SYGNAŁ 2 — W MYŚLENIU/EMOCJACH

— np. powrót „co jeśli”, nasilenie samokrytyki

CO ZROBIĘ?

— dziennik dowodów, kontakt z terapeutą

04 Realistyczne oczekiwania

NIEPOPRAWNE OCZEKIWANIE

„Wyleczę się — lęk zniknie — będę normalny/-a”. Cel niemożliwy → pacjent porzuca pracę, bo „nie działa”. Pułapka.

CEL REALISTYCZNY

„Życie pełnią *mimo* lęku. Schemat się aktywuje — wiem co robić. Codziennie krok w stronę wartości”.
Życie nie wbrew AvPD, ale obok niego.

Klucz: AvPD jest *chroniczne* — celem nie jest „brak lęku”, celem jest **życie pełnią mimo lęku**. Skodol 2005: PD poprawiają się z czasem, ale *tylko u pacjentów aktywnie utrzymujących pracę*. Schemat nie zanika — staje się cichszy, ale reaktywuje się pod stresem, chorobą, stratą. Plan utrzymania: **1 ekspozycja/tydz + monitor wstydu + booster co 3-6 mies. + samowspółczucie wobec potknięć**. Potknięcie ≠ porażka. Lista wczesnych sygnałów + odpowiadających działań, spisana, realistyczna. Bez konkretnego planu to deklaracja. Pierwsza krytyka po terapii nie cofa wszystkiego — jeśli pacjent *wie*, co robić.